

Retraso Global del Desarrollo

1. Introducción y relevancia clínica

El **retraso global del desarrollo (RGD)** corresponde a un **compromiso significativo en dos o más áreas del desarrollo psicomotor** —motora, cognitiva, del lenguaje o social— en un niño menor de 5 años, en comparación con lo esperado para su edad cronológica.

Constituye una **de las causas más frecuentes de derivación a neurología infantil** y un motivo habitual de preguntas en el **EUNACOM**, especialmente en temas de neurodesarrollo, tamizaje y manejo inicial.

Su detección precoz es esencial, pues **una intervención temprana y multidisciplinaria mejora el pronóstico funcional y cognitivo**.

El MINSAL, a través del **Programa Chile Crece Contigo**, establece protocolos nacionales para la evaluación, diagnóstico y derivación de niños con sospecha de RGD.

En Chile, se estima que entre **1% y 3% de los niños menores de 5 años** presentan algún grado de retraso global del desarrollo, siendo más frecuente en varones y en prematuros.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Concepto y definición

El **retraso global del desarrollo (RGD)** se define como un **desempeño 2 desviaciones estándar (DE) o más por debajo del promedio en al menos dos áreas del desarrollo**, evaluadas mediante instrumentos estandarizados (EEDP o TEPSI).

Áreas comprometidas:

1. Motora gruesa.
 2. Motora fina o coordinación.
 3. Lenguaje (comprensión o expresión).
 4. Social o adaptativa.
 5. Cognitiva (en mayores de 3 años).
-

2.2. Diferencia con otros trastornos

- **Retraso específico:** compromiso aislado en una sola área (por ejemplo, retraso del lenguaje).
 - **Retraso global:** compromiso en ≥ 2 áreas.
 - **Discapacidad intelectual:** diagnóstico posterior (después de los 5 años), cuando se demuestra un **CI <70** y limitaciones adaptativas persistentes.
 - **Trastorno del espectro autista (TEA):** alteración cualitativa en interacción social y comunicación, con o sin retraso global asociado.
-

2.3. Fisiopatología general

El RGD es un **síntoma o manifestación común de múltiples causas**, tanto estructurales como funcionales.

Las principales alteraciones fisiopatológicas incluyen:

- Daño estructural del SNC (malformaciones, hipoxia, hemorragias).
- Alteraciones genéticas o cromosómicas.
- Disfunciones metabólicas (hipotiroidismo, fenilcetonuria).
- Privación ambiental o de estimulación.
- Déficit sensorial (auditivo o visual).

En todos los casos, el resultado es una **disminución de la velocidad de maduración neurológica**, con repercusión en el desarrollo funcional del niño.

3. Clínica: signos, síntomas y diagnóstico diferencial

3.1. Manifestaciones clínicas iniciales

El RGD se sospecha cuando el niño **no alcanza los hitos del desarrollo esperados para su edad**, o cuando existe una **pérdida de habilidades previamente adquiridas**.

Algunos ejemplos clínicos:

- No sonríe a los 2 meses.
- No sostiene la cabeza a los 4 meses.
- No balbucea a los 6 meses.
- No se sienta a los 9 meses.
- No camina a los 18 meses.
- No dice palabras a los 2 años.

También puede observarse:

- Pobre contacto visual o social.
- Escasa interacción o juego.
- Hipotonía o hipertonía.
- Alteraciones en la alimentación, sueño o conducta.

Comentario EUNACOM:

La ausencia de **sonrisa social a los 2 meses, pinza superior al año o frases de dos palabras a los 2 años** son señales precoces de RGD.

3.2. Diagnóstico diferencial

1. Trastorno del espectro autista (TEA):

Retraso en interacción social y lenguaje, pero con áreas motoras a menudo preservadas.

2. Retraso del lenguaje aislado:

Resto del desarrollo normal; comprensión relativamente conservada.

3. Discapacidad intelectual:

RGD persistente más allá de los 5 años, con CI <70 y dificultades adaptativas.

4. Enfermedades neuromusculares:

Afectan motricidad gruesa con conservación de otras áreas.

5. Trastornos sensoriales:

Hipoacusia o déficit visual que interfieren con el aprendizaje.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Evaluación inicial

La evaluación debe comenzar con una **historia clínica completa**, explorando:

- Antecedentes prenatales (infecciones, exposición a tóxicos, prematuridad).
- Antecedentes perinatales (asfixia, ictericia, convulsiones neonatales).
- Antecedentes familiares (retrasos previos, consanguinidad).
- Factores ambientales (estimulación, vínculo, pobreza).

4.2. Examen físico

- Crecimiento y proporciones corporales.
 - Perímetro cefálico (micro o macrocefalia).
 - Tono muscular y reflejos.
 - Rasgos dismórficos (síndromes genéticos).
 - Evaluación visual y auditiva.
-

4.3. Exámenes complementarios dirigidos (según sospecha clínica)

1. Metabólicos:

- TSH, T4 libre (descartar hipotiroidismo).

- Aminoácidos plasmáticos, ácido láctico, amonio.
- Prueba del talón (PKU, hipotiroidismo congénito).

2. Genéticos:

- Cariotipo.
- Microarreglos cromosómicos (CMA).
- Estudios específicos (síndrome X frágil, Prader-Willi, Rett).

3. Neuroimagen:

- Resonancia magnética cerebral (RM): malformaciones, hipoxia, lesiones isquémicas.
- TAC si sospecha de calcificaciones o hemorragias.

4. Audiometría y evaluación visual.

5. Electroencefalograma (EEG): si hay crisis o alteraciones del tono.

4.4. Criterios diagnósticos de Retraso Global del Desarrollo

Según la OMS y MINSAL (Guía de Detección Temprana del Desarrollo, 2023), se diagnostica RGD cuando:

- El niño presenta un **desempeño 2 DE por debajo del promedio** en **≥2 áreas del desarrollo** (según EEDP o TEPSI).
- O bien, existe **retraso clínicamente evidente en hitos del desarrollo** confirmado en más de una evaluación.

5. Tratamiento y manejo (MINSAL 2023 / UpToDate 2024)

5.1. Principios generales

El tratamiento del RGD es **multidisciplinario y centrado en la familia**, orientado a estimular las áreas deficitarias, mejorar la funcionalidad y potenciar la autonomía del niño.

No existen fármacos curativos; la intervención se basa en **rehabilitación temprana y estimulación ambiental adecuada**.

5.2. Componentes del manejo

1. Estimulación temprana:

- Actividades dirigidas al juego, exploración y comunicación.
- Reforzar vínculo afectivo y confianza.

2. Terapias específicas:

- **Kinesioterapia:** motricidad gruesa.
- **Terapia ocupacional:** motricidad fina y autonomía.
- **Fonoaudiología:** lenguaje y comunicación.
- **Psicopedagogía:** cognición y aprendizaje.

3. Control médico integral:

- Evaluar crecimiento, nutrición y comorbilidades.
- Revisar vacunas y control preventivo.

4. Intervención familiar:

- Educación parental sobre estimulación en el hogar.
- Acompañamiento psicológico si es necesario.

5. Derivación a programas MINSAL:

- **Chile Crece Contigo y Red de Estimulación Temprana.**
-

5.3. Derivación especializada

Se debe derivar a **neurología infantil** o **genética** en los siguientes casos:

- Retraso grave o progresivo.

- Regresión de habilidades.
 - Discapacidad motora severa o convulsiones.
 - Microcefalia, macrocefalia o rasgos dismórficos.
 - Sospecha de trastorno metabólico o genético.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones

- Discapacidad intelectual permanente.
- Trastorno del lenguaje o del aprendizaje.
- Trastornos del espectro autista asociados.
- Problemas de conducta y adaptación escolar.
- Dependencia funcional prolongada.

6.2. Pronóstico

Depende de:

- Causa y severidad del retraso.
- Edad de inicio de la intervención.
- Nivel sociofamiliar de apoyo.
- Presencia de comorbilidades neurológicas o sensoriales.

Los mejores resultados se logran con **detección e intervención antes de los 2 años**.

El retraso asociado a **privación ambiental o desnutrición** tiene buen pronóstico si se corrige la causa.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. El **retraso global del desarrollo** compromete **≥2 áreas del DSM**.
2. **EEDP** y **TEPSI** son herramientas de tamizaje, no de diagnóstico definitivo.
3. El **manejo inicial** es la **estimulación temprana** en todos los casos.
4. **Derivar a neurología infantil** si hay regresión, microcefalia o dismorfias.
5. En **EUNACOM**, las preguntas enfatizan en reconocer hitos ausentes y conducta médica apropiada.

Errores comunes:

- Esperar sin actuar ante sospecha de retraso.
 - Interpretar una sola medición del test sin contexto.
 - No corregir edad en prematuros.
 - No incluir a la familia en la intervención.
 - Solicitar exámenes sin una hipótesis clínica clara.
-

8. Resumen final (6 ideas clave)

1. El **retraso global del desarrollo (RGD)** implica compromiso en dos o más áreas del DSM, **≥2 DE** bajo lo esperado.
2. Las causas son múltiples: genéticas, neurológicas, metabólicas o ambientales.
3. El **diagnóstico** se basa en la clínica y las escalas EEDP o TEPSI.
4. El **manejo principal** es la estimulación temprana y el abordaje multidisciplinario.
5. La **derivación especializada** se indica ante retraso grave, regresión o sospecha de causa orgánica.
6. En **EUNACOM**, se evalúa la identificación de hitos alterados y la conducta médica adecuada (estimulación + derivación según severidad).